

	Hôpital Bicêtre	Procédure Réf : Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.
	 APPENDICECTOMIE PAR COELIOSCOPIE	Version : 1
		Date d'application : Date d'application
		Date de fin de validité : Date de limite de validité
		Page 1 sur 4

	NOM, FONCTION	DATE
RÉDACTION		Date de rédaction
VALIDATION		Date de validation
APPROBATION	SMQ-APPROBATEURS	Date d'approbation

Groupe de travail :

Principales modifications par rapport à la version précédente : smq-objet-modif

1. OBJET

Cette fiche décrit vla procédure et le matériel nécessaire lors d'une appendicectomie par coelioscopie.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique au bloc opératoire commun du CHU de Bicêtre.

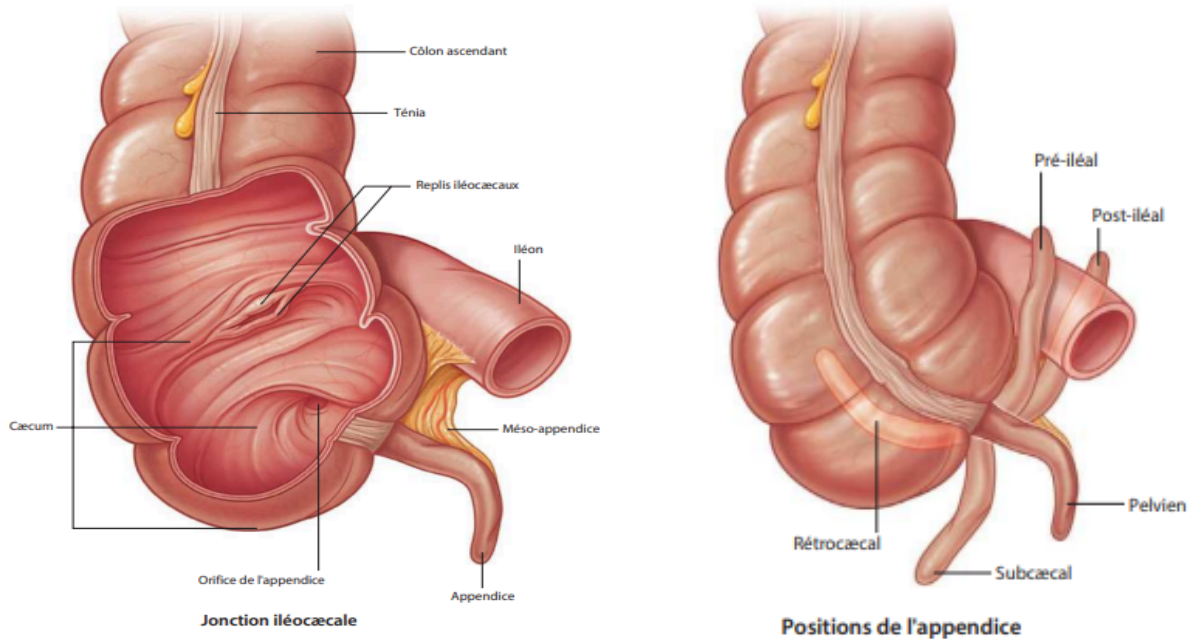
3. RESPONSABILITÉS/ PERSONNES CONCERNÉES

IBODE, IDE, EIBODE, chirurgiens, internes en chirurgie, externes.

4. DESCRIPTION

Définition :

L'**appendicectomie par coelioscopie** est une **intervention chirurgicale mini-invasive** consistant à réaliser l'**ablation de l'appendice vermiforme par voie laparoscopique**, à l'aide de trocars et d'une caméra, le plus souvent dans le cadre d'une **appendicite aiguë**.



But :

- Traiter l'**appendicite aiguë** (simple, suppurée ou compliquée)
- Éviter l'évolution vers :
 - péritonite
 - abcès
 - perforation
- Permettre un **diagnostic et traitement simultanés** en cas de doute diagnostique
- Réduire la morbidité postopératoire grâce à l'approche mini-invasive

Abord

- Open coelio et mise en plac trocart de 11 (ombilical)
- Création d'un **pneumopéritoine**
- Mise en place des **2 trocars de 5** (fosse iliaque gauche, sus-pubien)

Principe :

Exploration

- Inspection de la cavité abdominale
- Identification de l'appendice
- Évaluation du caractère simple ou compliqué

Temps opératoire

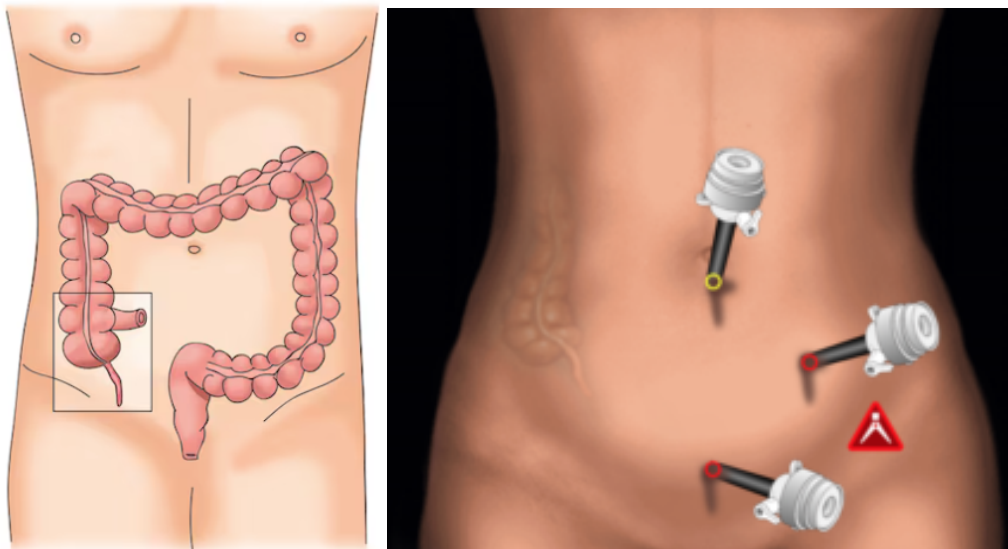
- Dissection et section du **méso appendice**
- Ligature ou section de la **base appendiculaire**
- Section de l'appendice
- Extraction dans un **sac endoscopique**

Contrôle et fin d'intervention

- Lavage péritonéal si nécessaire
- Hémostase
- Ablation des trocars
- Fermeture cutanée **Temps aseptique**

Avantages de la coelioscopie

- Moins de douleur postopératoire
- Hospitalisation plus courte
- Récupération plus rapide
- Meilleur résultat esthétique
- Exploration abdominale complète



Installation :

Patient installé en décubitus dorsal, bras gauche le long du corps, colonne vidéo positionnée à droite.
vérification d'une miction préalable avant la descente au bloc opératoire, avec réalisation d'un sondage vésical évacuateur si nécessaire.

Matériel :

Mobile : 2 grandes tables 1 petite table

Techniques : Colonne vidéo. GHF

Installation : Table opératoire, Géloses

DMRS

Boîte Coelio
Optique 0° ou 30°

Consommables : DM & DMS

Pack universel	Casaques	Electrode neutre	Plateau badigeon
Tubulure d'insufflation	Poignée de scialytique	Housse caméra	Trocarts Ø 5
Champ abdominaux	Poche à instruments coelio	Compressees RX	Trocarts Ø 10
Endoloop Vicryl ou PDS	Sac de recueil endoscopie type GR1	Compressees NT	Lame 11

Aspiration coelio Ø 5	Matériel pour sondage		

Pharmacie :

Bétadine jaune

Bétadine rouge

Sérum physiologique

Examen :

Anatomo-pathologie



Prévoir le matériel pour la conversion (cf fiche)